

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Рубрика: ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Автор: Никитин А.В.
 Первый МГМУ имени И.М. Сеченова

В статье рассмотрены принципы противоэпидемического обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний. При подготовке публикации использованы материалы одноименных методических указаний, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ и введенных в действие с 25 мая 2026 года. Статья предназначена для всех специалистов в области ГОЧС. Более подробную информацию по организации противоэпидемических мероприятий в условиях ЧС (алгоритмы действий, методы дезинфекции, расчет потребностей сил и средств и т.п.) можно найти в приложениях к упомянутым методическим указаниям¹².

Большинство чрезвычайных ситуаций из-за нарушения систем жизнеобеспечения населения сопровождается ухудшением санитарно-эпидемической обстановки, а формирование очагов опасных инфекционных заболеваний само по себе является чрезвычайной ситуацией¹³. Все это требует проведения соответствующих противоэпидемических мероприятий. Противоэпидемическое обеспечение в условиях ЧС представляет собой комплекс мер, направленный на недопущение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней среди людей в зоне ЧС различного характера.

Противоэпидемическое обеспечение проводится на всех этапах ликвидации последствий ЧС, включая передвижение, транспортировку, размещение населения, период восстановительных работ и адаптационный период перемещенного населения на новом месте жительства или при возвращении в места прежнего проживания.

Противоэпидемические мероприятия проводятся в рамках функциональной подсистемы надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер по противоэпидемическому обеспечению организуют

территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) при координирующей роли Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. По его решению проводится усиление территориальных подразделений, в том числе, специализированной противоэпидемической бригадой (далее – СПЭБ) Роспотребнадзора.

Основными принципами противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС являются:

- использование всей нормативно-методической базы санитарного законодательства Российской Федерации;
- приоритетность превентивных мер по недопущению заноса инфекции и формирования эпидемических очагов;
- единый подход к организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с построением общей системы противодействия факторам катастрофы;
- постоянная готовность сил и средств органов Роспотребнадзора;
- соответствие содержания и объема санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий санитарно-эпидемиологической обстановке с учетом прогнозирования;
- межведомственное взаимодействие, в том числе с органами исполнительной власти субъекта РФ.

Массивные разрушения социальной инфраструктуры и коммунально-бытовых систем на фоне стрессовых факторов в районах природных, техногенных и социальных катастроф влекут за собой санитарно-эпидемиологическое неблагополучие населения региона, которое приводит к созданию условий для активизации путей передачи инфекций и формированию очагов групповой заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями среди населения и (или) в организованных коллективах как естественного, так и искусственного происхождения (акты биотерроризма).

Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия в зонах ЧС характеризуются проблемами жизнеобеспечения пострадавшего населения, что требует проведения многопланового комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки.

При планировании противоэпидемической работы в зоне ЧС следует учитывать, что вероятность появления инфекционных заболеваний среди эвакуированных в местах их временного размещения прямо коррелирует с длительностью воздействия неблагоприятных факторов при их нахождении в зоне ЧС. Под воздействием

негативных факторов, формирующих и сопровождающих ЧС, активизируется механизм передачи возбудителей инфекционных заболеваний, что приводит к сокращению инкубационного периода заболеваний до минимального, а также к увеличению количества инфицированных лиц, которые могут рассматриваться в качестве источника инфекции.

Активизируются существующие природные очаги зооантропонозных инфекций, профилактическую работу в отношении которых необходимо проводить с учетом времени года.

На фоне снижения резистентности организма у переселенцев, страдающих хроническими инфекциями органов дыхания (например, туберкулезом), возможна активизация инфекционного процесса и, как следствие, массивное выделение возбудителя заболевания во внешнюю среду, что необходимо учитывать при планировании мероприятий.

Вследствие резкого ухудшения санитарно-бытовых условий возможно распространение среди пострадавшего населения паразитозов: педикулеза и чесотки.

Источники зооантропонозных инфекций чаще всего находятся среди пострадавшего населения, включая перемещенных лиц, но возможен занос инфекции спасателями, а также местным населением при контакте с ним в местах временного размещения.

Наиболее вероятными эпидемиологическими осложнениями в местах временного размещения остаются острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы (например, ротавирусная, норовирусная и энтеровирусная инфекции, шигеллезы, сальмонеллезы, брюшной тиф и паратифы, вирусный гепатит А), острые респираторные инфекции (например, дифтерия, менингококковая инфекция, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп, COVID-19, корь, паротит).

Эпидемический очаг в районах стихийных бедствий, техногенных и социальных катастроф имеет следующие характерные особенности:

- массовое заражение людей и формирование множественных очагов за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекций в зонах массовых разрушений;
- длительность действия очага (особенно природно-очаговых инфекций) из-за продолжающегося заражающего действия невыявленных источников;
- уменьшение периода проявления заболевания от момента заражения в результате постоянного контакта с невыявленными источниками инфекции, снижение резистентности организма человека и большой инфицирующей дозы возбудителей;
- отсутствие защиты населения и пораженных от контакта с заразными больными в связи с несвоевременной изоляцией инфекционных больных;

- наличие различных клинических форм инфекционных болезней и несвоевременность диагностики и лечения.

Все это требует проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с целью недопущения заноса и распространения инфекций различного происхождения, формирования эпидемических очагов, как среди пострадавшего населения, так и среди сотрудников, занимающихся ликвидацией ЧС.

Основными направлениями противоэпидемической работы в зоне ЧС, являются:

- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, как на этапах эвакуации, так и в местах временного проживания пострадавшего населения;
- оценка готовности медицинских организаций и лабораторной базы к приему пациентов с опасными инфекционными заболеваниями и массовому поступлению больных с инфекционными заболеваниями;
- организация гигиенической экспертизы, мониторинга и лабораторного контроля качества продовольствия, питьевой воды, воздушной среды, почвы;
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, органами государственной власти и другими заинтересованными ведомствами, функционирующими в зоне ЧС;
- оценка санитарно-эпидемиологической обстановки и ее прогнозирование, планирование, мониторинг, контроль и оптимизация комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- организация проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса, возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения;
- организация иммунизации по эпидемическим показаниям и экстренной профилактики (бактериофаги, противовирусные, иммуномодулирующие средства) определенным контингентам населения, перемещенным лицам;
- организация активного мониторинга за инфекционной и паразитарной заболеваемостью населения, проведение оперативного эпидемиологического анализа, организация быстрого реагирования при регистрации случаев инфекционных заболеваний с изоляцией больных, выявлением лиц, подвергшихся риску заражения, организацией дезинфекционных мероприятий и мероприятий экстренной профилактики;

- эпидемиологическое расследование случаев инфекционных и паразитарных болезней с установлением причинно-следственной связи формирования очагов;
- организация комплекса мер по локализации и ликвидации эпидемических очагов различного происхождения, в том числе при биотеррористических актах;
- санитарный контроль за захоронением умерших от инфекционных заболеваний и внесение предложений по захоронению погибших;
- контроль за проведением мероприятий по борьбе с переносчиками трансмиссивных заболеваний и грызунами;
- проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Организация противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС

При возникновении ЧС территориальные органы Роспотребнадзора немедленно вносят предложение Главе субъекта РФ или муниципального образования о введении в действие Плана противоэпидемического обеспечения конкретной территории в условиях ЧС (далее – План). Такие планы готовятся и согласовываются со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с территориальными подразделениями МЧС России и МВД России, заранее.

В Пlane предусматриваются разделы с указанием ответственных лиц и исполнителей в соответствии с основными направлениями противоэпидемической работы. Положения Плана могут вноситься в общий План действий на уровне субъекта РФ и закрепляться решением чрезвычайных комиссий или других координирующих органов.

План является динамичным документом и актуализируется по мере развития ситуации.

При составлении Плана целесообразно использовать имеющиеся документы, например, Программы и Планы по санитарной охране территории, ликвидации очагов опасных инфекционных болезней, оперативного оповещения на территории.

Отдельным приложением к Плану формируется Порядок оперативного реагирования при возникновении случаев, подозрительных на опасное инфекционное заболевание¹⁴.

В зоне ЧС формируется оперативный межведомственный штаб, возглавляемый представителями органов исполнительной власти субъекта РФ, в котором обязательно принимают участие представители органов федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в населенных пунктах, а также при следовании лиц из зоны ЧС авиатранспортом, автотранспортом и водным транспортом организуются закрепленными территориальными органами Роспотребнадзора. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в отношении лиц, следующих железнодорожным транспортом, организуются органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) на железнодорожном транспорте.

Территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), на этапах перемещения (эвакуации) населения организуют:

- оценку и контроль за соблюдением санитарных требований к размещению эвакуированного населения;
- участие в выборе и оборудовании помещений в местах отправки, прибытия и окончательного размещения;
- организацию медицинских осмотров эвакуируемых и мероприятий по санитарной обработке;
- организацию и контроль за профилактическими мерами по эпидемическим показаниям (иммунизация, экстренная профилактика);
- организацию и проведение санитарно-эпидемиологического надзора во время следования в поездах, судах, на автотранспорте, на самолетах;
- осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за местами питания и водоснабжения.

Ответственные лица за санитарно-противоэпидемическое обеспечение эвакуируемых осуществляют постоянную связь с ответственными представителями органов, осуществляющих эвакуацию пострадавшего населения.

При оценке условий размещения пострадавшего населения органы руководствуются методическими рекомендациями «[МР 1.1.0093-14](#). Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.09.2009).

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в пути следования включают:

- выявление, изоляцию и госпитализацию инфекционных больных в близлежащие больницы, расположенные на путях эвакуации;

- установление медицинского наблюдения за контактными лицами;
- организацию контроля за питанием, обеспечением доброкачественной питьевой водой;
- проведение дезинфекционных мероприятий.

Примечания

12. Примечание редакции. Полное название документа – МУ 3.1.4165-25. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.07.2025). Прежние Методические указания по противоэпидемическому обеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций (МУ 3.1.3260-15) утратили свою силу с 25 мая 2026 года.. Обратите внимание, что продолжают действовать методические рекомендации по санитарно-противоэпидемическому обеспечению пострадавших и вынужденных переселенцев в чрезвычайной ситуации (утв. Минздравом России 24.09.2001 N 2510/9978-01-34).

13. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

14. Глава 4 МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.09.2009).